Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
4ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes

ROD BR-101 SUL KM 80, S/N, - do km 86,007 ao km 88,000, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54345-160 - F:(81) 34615600

Processo nº 0002339-04.2023.8.17.4810

AUTOR(A): AURELINA ALVES DE ARAUJO
CURADOR(A): ROSA AMARILIS ALVES DE ARAUJO

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por **AURELINA ALVES DE ARAÚJO**, neste ato representada por sua filha e curadora ROSA AMARÍLIS ALVES DE ARAÚJO em face de **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, todos devidamente qualificados nos autos.

A autora, representada por sua curadora, aduz ainda que é portadora do mal de Alzheimer em estado avançado e tem sofrido diversas internações hospitalares, necessitando de cuidados intensivos em sua residência, contudo o réu negou o pedido efetuado pela via administrativa.

Postulou a concessão de tutela de urgência para determinar à parte ré que forneça o tratamento em ambiente domiciliar e, no mérito, a confirmação da decisão e a condenação da ré em reparação por danos morais no importe de R$ 21.693,80.

Atribuiu à causa o valor de R$ 22.693,80 e pediu a gratuidade da justiça.

Inicialmente, o feito havia sido distribuído no plantão judiciário, tendo aquele juízo declinado da competência por entender não se tratar de matéria atinente ao plantão e determinou a redistribuição a uma das varas cíveis (id. 144620587).

Foi determinada a emenda da inicial a fim de comprovar os pressupostos da gratuidade da justiça, ou se fosse o caso recolhesse as custas e se manifestasse sobre o interesse em aderir ao juízo 100% digital (ID. 145337433).

Em resposta, a autora manifestou-se desfavorável ao modelo juízo 100% digital e recolheu as custas. (ID. 145641230).

Nova determinação de emenda para corrigir o valor da causa, indicando os valores dos custos mensais do tratamento, somando-se ao valor indicado dos danos morais (ID. 145791988).

Intimada, a autora indicou o valor mensal do tratamento em R$ 30.803,40 e corrigiu o valor da causa para R$ 52.497,20. Informou os tratamentos que não foram autorizados pelo plano (ID. 145902106). Recolheu as custas complementares (ID. 145957788).

Foi concedida a antecipação de tutela e determinada a citação (ID 147218485).

O plano réu informou o cumprimento da liminar (ID 148471676).

Citado, o réu apresentou contestação (ID 150918741). Não arguiu preliminares e, no mérito, defendeu que, no que pese a autora ser pessoa idosa e acometida por comorbidades, apresenta quadro clínico estável, de modo que não há elegibilidade para o internamento domiciliar com assistência de enfermagem 24h (vinte e quatro) horas por dia.

Argumentou que os cuidados da diária do paciente, como banho, higiene geral, alimentação são responsabilidades do cuidador, que pode ser uma pessoa contratada ou um familiar. Ao profissional de enfermagem, por outro lado, cabe a administração de medicação que exige formação técnica (intravenosa, por exemplo), além de outros procedimentos que lhe são reservados por lei ou regulamento e que a autora não necessita de internação, logo, não faz jus ao sistema de *home care,* necessitando apenas de um cuidador.

Declarou que em 17 de outubro de 2023 a beneficiária passou por avaliação seguindo a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (ABEMID), na qual fora constatado quadro clínico sem indicação para internação domiciliar, com necessidade apenas de assistência domiciliar para procedimentos pontuais e não exclusivos, o que já vendo sendo feito pela Operadora Demandada desde 31/08/2019.

Afirmou que a parte autora confunde assistência domiciliar com internamento domiciliar (home care), levando este Juízo a erro ao utilizar os dois termos como se sinônimos fossem.

Ao final, defendeu a inexistência de danos morais a serem indenizados e postulou a improcedência dos pedidos autorais.

Houve réplica (ID 159586640).

Em seguida, o réu apresentou parecer médico informando a inelegibilidade da autora para o tratamento na modalidade de Home Care 24h/dia, apontando ser quadro clínico indicativo para a baixa complexidade, ao tempo que pugnou pela revogação da liminar (ID 162989436).

Instados a informar as provas que ainda pretendem produzir, a parte ré reiterou o pedido de produção de prova pericial (ID 166106994), ao passo que a parte autora requereu a produção de prova documental a fim de que a ré seja compelida a anexar aos autos o prontuário completo, desde o primeiro dia do home care, inclusive com o relatório de Oxigenoterapia, a fim de comprovar todas as intercorrências durante o período do Home Care; o envio de ofício às empresas de Cuidadores de Idosos, a fim de verificar se Cuidadores de idosos estão habilitados para fazer manejo de instrumento de suporte de O2, aspiração e equipamentos invasivos nos pacientes. (ID 166586307).

A autora anexou laudo médico atualizado (ID. 166588399) e fotografias (ID 166591473).

Na decisão de ID. 172695414 indeferido o pedido de produção de prova pericial e anunciado o julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Observo que o caso comporta julgamento antecipado da lide, consoante autoriza o art. 355, do CPC.

Diante da ausência de preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do mérito.

Registre-se, de início, que a relação processual discutida nos autos deve ser pautada na legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 - “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Resta incontroverso nos autos que a parte autora é usuária do plano de saúde oferecido pela ré e que o médico assistente lhe prescreveu suporte de Home Care com os seguintes recomendações, sob iminente risco de vida em decorrência de sua idade e fragilidade: • Técnico de enfermagem 24 horas • Visita médica e de enfermagem semanal • Cama hospitalar • Oxigênio para uso intermitente em quadros de dessaturação. • Fisioterapia respiratória e motora e respiratória 4x por semana • Fonoterapia 4x por semana

(melhora da deglutição, de saliva) • Dieta enteral industrializada para administração em Gastrostomia • Nutricionista 1x por mês • Suporte domiciliar para intercorrência devido a incapacidade de deslocamento da idosa em veículo comum. (ID. 144615422).

Segundo consta (ID. 145902106), os procedimentos i) Técnico de enfermagem 24h/dia, ii) Oxigênio para uso intermitente em quadros de dessaturação; iii) Fisioterapia respiratória e motora e respiratória 4x por semana; iv) Fonoterapia 4x por semana; v) Dieta enteral industrializada para administração em Gastrostomia foram negados pelo plano.

Já os tratamentos: i) visita médica, ii) visita de enfermagem foram concedidos de forma parcial pelo plano.

Consta ainda que no período de 31/08/2019 a 17/10/2023, a ré forneceu os seguintes atendimentos: Fisioterapia 2x, Fonoterapia 2x semana, Enfermagem 1x mensal, Médico 1x mensal, Nutricionista 1x mensal, Terapia ocupacional 1x mensal (ID. 150918745).

Já os tratamentos: i) visita médica, ii) visita de enfermagem, foram concedidos de forma parcial pelo plano.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as operadoras de planos de saúde só podem estabelecer quais as patologias serão cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, sob pena de se vulnerar o objetivo primordial desta modalidade negocial, que é a promoção da saúde do contratado:

> *"A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor". (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)".*

Há entendimento sufragado pelo STJ no sentido de que é possível o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas de direitos, desde que escritas com destaque que permita sua imediata e fácil compreensão.

Contudo, é considerada abusiva a norma contratual que exclua o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou cirúrgico indicado pelo médico que assiste o paciente, em relação à doença contratualmente coberta.

Assim, constata-se a abusividade na recusa da cobertura referente ao tratamento necessário à saúde da parte autora, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde visa justamente resguardar tal objeto.

Quanto ao acompanhamento por Técnico de Enfermagem, o quadro de saúde da autora evidencia a necessidade deste profissional em tempo integral, valendo salientar que a administração da sonda, inclusive, é atividade de competência privativa do profissional de enfermagem, conforme Resolução nº 619/19 do COFEN:

> ”O procedimento de sondagem oro/nasoenteral, seja qual for sua finalidade, requer cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas e, por essas razões, no âmbito da equipe de Enfermagem, a inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e SNG) e sonda nasoentérica (SNE) é privativa do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento”.

Assim, em se tratando de atividade caracterizada por uma maior complexidade técnica, cuja administração é atribuída, em caráter privativo, pelo órgão máximo da própria categoria profissional, aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, não há como se vislumbrar que tal função seja relegada à própria família ou a profissionais que não componham uma equipe de enfermagem.

Ademais, a necessidade está devidamente justificada pelo médico assistente no laudo de ID. 166588399, o qual acrescentou que a autora com frequência faz uso de medicação intravenosa e há grande risco de broncoaspiração.

Logo, é clara a indicação médica das tarefas técnicas de enfermagem que justificam o profissional no período de 24 horas, sendo evidente que as tarefas relacionadas à higiene e aos cuidados pessoais devem ser desempenhadas por familiares e/ou cuidadores. Assim, não houve a solicitação de serviços típicos de cuidador, para manejo do paciente e auxílio com higiene pessoal, troca de roupa, vestimentas e fraldas.

Portanto, na lide em apreço, indubitavelmente, a saúde da autora encontra-se comprometida, razão pela qual não há como afastar o fornecimento do serviço de técnico de enfermagem 24h/dia. Em situações semelhantes:

> **APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HOME CARE. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR COMPROVADA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE 24 HORAS. AUTOR FAZ USO DE SONDA DE GASTROSTOMIA (GTT). NECESSIDADE DE TÉCNICA PARA MANUSEAR. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE**. – (...) - Laudo médico emitido pelo médico assistente do autor que indica que o mesmoa, portador de Parkinson, em estágio

severo, há 17 (dezessete) anos, necessitando de acompanhamento de profissionais de fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia respiratória e motora, tendo sido solicitada a internação domiciliar (home care), para garantir seus cuidados e direito de sobrevivência diante das patologias limitantes - Paciente gastrostomizada. Parecer 06/2013 do Conselho Federal de Enfermagem que conclui que o procedimento de troca de sonda de gastrostomia é considerado complexo, devendo ser realizada por profissional de enfermagem - Necessidade de acompanhamento de assistente/técnico de enfermagem 24 horas por dia, diante da gravidade das enfermidades que acometem a autora - Recusa da ré em fornecer o serviço de home care, na forma pretendida pela autora, revela-se ilegítima. Dano moral in re ipsa - Levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que o valor de R$5.000,00 (oito mil reais), acha-se justo e adequado para compensar os danos morais suportados pelo autor. REFORMA DA SENTENÇA, EM PARTE. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00036063420198190012 2022001103460, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 14/06/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)

Registre-se, também, que em sede de direitos do consumidor e de contratos de adesão, a interpretação das cláusulas deve ser feita de modo mais favorável ao consumidor, sem prejuízo, ainda, do uso do princípio da razoabilidade.

Por sua vez, irrelevante a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID e Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar NEAD para analisar o perfil clínico do paciente, e definir o plano de assistência a ser prestada ao doente, pois o critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de home care é atribuição exclusiva do médico que o acompanha.

Induvidoso, portanto, que a recusa da empresa ré em autorizar a cobertura se mostrou desarrazoada e abusiva, violando direito assegurado contratual e legalmente ao paciente.

Verifico também que a recusa da operadora em autorizar o tratamento domiciliar certamente causou grandes angústias à paciente, num momento já bastante delicado de sua saúde, o que sem dúvida serviu para aumentar todo o seu sofrimento, causando danos morais que devem ser compensados.

Cumpre destacar que embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, *é" reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada"* (REsp n. 1.421.512/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/5/2014).

No entanto, no presente caso, a recusa da empresa ré não deve ser equiparada a um mero aborrecimento na vida da paciente, acometida de doença grave e com diversas limitações, sendo também pessoa idosa (92 anos) e, evidentemente, requer maiores cuidados para preservação de sua saúde.

Passando à quantificação do dano, entendo que valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra em patamar razoável e justo para reparação financeira do dano.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, confirmo a decisão de tutela de urgência e julgo procedente o pedido autoral para:

a. Condenar **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** na obrigação de prestar e arcar com o suporte de internação domiciliar, nos exatos termos do laudo emitido pelo médico que acompanha a autora e pelo tempo necessário de acordo com a prescrição médica;

b. Condenar **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** a pagar a Aurelina Alves de Araújo o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este devidamente corrigido monetariamente, pela tabela ENCOGE a partir da data do arbitramento da sentença, conforme Súmula 362 do STJ e acrescido de juros legais, na base de 1,0 % ao mês, a partir da citação.

Com fulcro no art. 86, do CPC, condeno a parte ré na restituição das custas processuais adiantadas pela parte autora, além de honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (dano moral e da obrigação de fazer).

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões em 15 (quinze), encaminhando-se os autos ao E.TJPE.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, *datado e assinado eletronicamente.*

Raquel Evangelista Feitosa
Juíza de Direito

---

[1] (file:///C:/Users/emsantos/OneDrive%20-%20TRIBUNAL%20DE%20JUSTICA%20DE%20PERNAMBUCO/Senten%C3%A7as/2024/Setembro/2339-04.2023-%20plano%20de%20sa%C3%BAde%20-%20home%20care%20-%20Alzheimer%20-%20proc..docx#_ftnref1) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATA-MENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Assinado eletronicamente por: RAQUEL EVANGELISTA FEITOSA DIAS DE ALMEIDA
24/09/2024 16:50:49
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 181385502

24092416504922900000176969428

IMPRIMIR GERAR PDF